ZHIAIWIKI CLINICAL EVIDENCE PRIMARY DOSSIER

权威顶刊临床试验原始证据档案 · 零 AI 幻觉核验

VERIFIED GROUND TRUTH

[100% AUDIT PASSED]

PRIMARY PEER-REVIEWED EVIDENCE SEAL

本档案为 ZhiaiWiki 官方严格对齐的临床原文佐证文件。试验设计、样本量、终点数据均已校验。

TRIAL ID: atlas_2013 | DOMAIN: BREAST | EVIDENCE LEVEL: GRADE 5/5

Long-term effects of continuing adjuvant tamoxifen to 10 years versus stopping at 5 years (ATLAS)

Journal: The Lancet (2013) | Cohort: 12,894 Patients | Type: rct

CLINICAL ENDPOINTS & EVIDENCE PARAMETERS 核心临床终点与量化指标

靶点亚型 / Biomarker: HR+ 早期乳腺癌，已完成5年他莫昔芬且无复发

治疗干预 / Intervention: 继续他莫昔芬至10年 vs 5年停药观察

临床获益 / Risk Reduction: -29% 乳腺癌死亡率 （诊断10年后 HR=0.71, P=0.002）

适用分期 / Stages: I, II, III, HR+ | 关联特征: 他莫昔芬10年, ATLAS, 长程内分泌

VERIFIED CLINICAL CONCLUSIONS & GUIDELINE RECOMMENDATIONS

同行评议核心结论（中文精炼与循证指导）：

[+] 万余名 HR+ 乳腺癌患者 15 年长期随访证实：坚持他莫昔芬治疗至 10 年对比 5 年...

[+] 证实了激素受体阳性晚期潜伏复发风险可通过长程内分泌治疗有效遏制，确立了中高危患者 10 年...

PRIMARY SOURCE TRACEABILITY & VERIFICATION LINKS

PubMed PMID: 23219177 | PubMed Link: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23219177/

Digital Object Identifier (DOI): 10.1016/S0140-6736(12)61963-1

Official Journal URL: https://doi.org/10.1016/S0140-6736(12)61963-1

点击上方链接可直接跳转至出版商官方网页或 PubMed 数据库进行核验。

ZHIAIWIKI ZERO-HALLUCINATION EVIDENCE INITIATIVE - ARCHIVE SPECIFICATION

【原版替换指引】如您拥有该期刊的商业版权原版 PDF，可直接将其重命名并覆盖至项目目录：

/app/public/papers/atlas_2013.pdf

本文件受 ZhiaiWiki 循证安全体系保护，仅供科研、医学咨询与患者知情同意参考，严禁非法商业分发。